PANDUAN PENYULUHAN

PERAWATAN IBU HAMIL DENGAN HIPERTENSI

Disusun oleh Mahasiswa STIKes Widya Darma Husada :

Mirwan
Nurlia Shalma
Pardiyah
Putri Aulia

DAFTAR ISI

BAB 1. PENDAHULUAN 1

1. PENGERTIAN HIPERTENSI PADA IBU HAMIL 1

2. PATOFISIOLOGI HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN 1

3. KLASIFIKASI HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN 2

4. TANDA DAN GEJALA HIPERTENSI PADA IBU HAMIL 2

5. FAKTOR RISIKO HIPERTENSI PADA IBU HAMIL 2

6. DAMPAK HIPERTENSI TERHADAP IBU DAN JANIN 3

BAB 2. PERAWATAN IBU HAMIL DENGAN HIPERTENSI 4

1. PERAWATAN FARMAKOLOGIS 4

DAFTAR ISI

1. PERAWATAN NON-FARMAKOLOGIS 5

2. PENERAPAN GAYA HIDUP SEHAT DAN POLA MAKAN SEIMBANG 6

3. PENCEGAHAN KOMPLIKASI HIPERTENSI DALAM KEHAMILAN 7

BAB 3. PERAN KADER DALAM PENYULUHAN 8

1. TUGAS DAN FUNGSI KADER DALAM UPAYA PROMOTIF DAN PREVENTIF 8

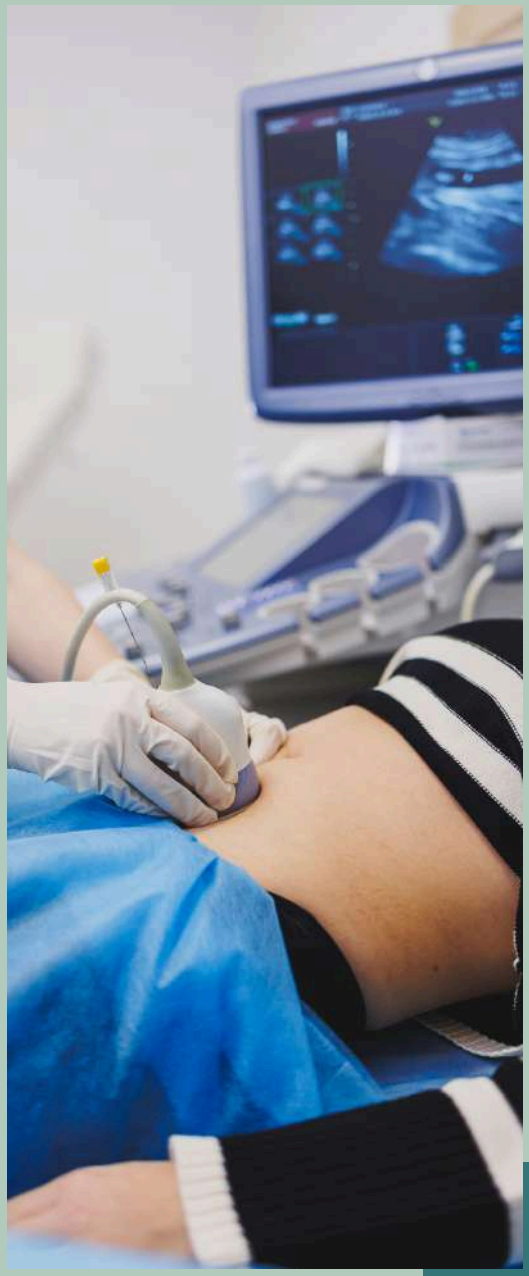
2. LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN PENYULUHAN 10

3. TEKNIK KOMUNIKASI 11

4. CARA MENENTUKAN HIPERTENSI PADA IBU HAMIL 12

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB 1
PENDAHULUAN



1. Pengertian Hipertensi pada Ibu Hamil

Hipertensi pada kehamilan adalah kondisi tekanan darah tinggi yang terjadi selama masa kehamilan, dengan tekanan darah sistolik ⩾140 mmHg dan/atau diastolik ⩾90 mmHg.

	Tekanan Sistolik (mmHg)	Tekanan Diastolik (mmHg)
Normal	120-129	80-84
Tinggi Normal	130-139	85-89
Hipertensi tahap 1	140-159	90-99
Hipertensi tahap 2	160-179	100-109
Hipertensi tahap 3	≥180	≥110

(Kemenkes RI, 2021)

2. Proses Perjalanan Penyakit Hipertensi dalam Kehamilan

Hipertensi kehamilan terjadi akibat gangguan pada pembuluh darah plasenta yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan peningkatan tekanan darah.

3. Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan

Jenis	Keterangan
Hipertensi Gestasional	Muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa proteinuria
Preeklampsia	Hipertensi disertai protein dalam urin
Eklampsia	Preeklampsia disertai kejang
Hipertensi Kronik	Hipertensi yang sudah ada sebelum hamil

4. Tanda dan Gejala Hipertensi pada Ibu Hamil

- Sakit kepala hebat
- Pandangan kabur
- Nyeri ulu hati
- Bengkak pada wajah, tangan, dan kaki
- Mual dan muntah berlebihan
- protein dalam urine

5. Faktor Risiko Hipertensi pada Ibu Hamil

- Kehamilan pertama
- Usia <20 tahun atau >40 tahun
- Obesitas
- Riwayat hipertensi kronis sebelum hamil
- Kehamilan kembar
- Diabetes
- ginjal kronis
- riwayat preeklamsi

6. Dampak Hipertensi terhadap Ibu dan Janin

Dampak pada Ibu:

- Jantung
- Gagal ginjal
- Kerusakan hati
- kematian ibu

Dampak pada Janin

- Pertumbuhan terhambat

- Kelahiran prematur

- Berat badan lahir rendah

- kematian Neonatus dini : kematian bayi lahir hidup yang terjadi dalam 7 hari pertama kehidupan (0-7 hari atau <168 jam)

BAB II PERAWATAN IBU HAMIL DENGAN HIPERTENSI

1. Perawatan Farmakologis

Menurut ACC/AHA 2017 dan ESC/ESH 2018 obat antihipertensi ada kehamilan yang direkomendasikan :

1. labetalol
   - Labetalol adalah obat pilihan untuk penurun hipertensi pada kehamilan Labetalol adalah golongan Beta blockers-combined alphaand beta-receptor, dosisnya 200-800 mg, diberikan 2 kali sehari
2. methyldopa
   - Methyldopa adalah golongan central alpha 1- agonist and other centrally acting drugs, dosisnya 250-1000 mg, diberikan 2 kali sehari.
3. nifedipine
   - Nifedipine adalah golongan CCB-dihydropyridines, yang dianjurkan adalah long acting (Nifedipine LA / adalat oros ®)
4. Clonidine
   - Clonidine adalah golongan centrally acting α2 adrenergic agonist and imidazoline receptor agonist. Biasa digunakan untuk pengobatan
     Aliskiren hipertensi yang dapat menimbulkan efek samping seperti gangguan menjadi tidak aktif, kecemasan, withdrawal syndrome, migrain dan gejala nyeri kronik. Bisa juga digunakan sebagai obat anti muntah pada hyperemesis gravidarum (HG).
5. Diuretik
   - Diuretik dipakai secara luas pada pengobatan hipertensi non kehamilan

Sedangkan yang dilarang adalah ACE inhibitor, ARB dan direct renin inhibitors (Aliskiren)

Note : obat harus sesuai dengan anjuran dokter

2. Perawatan Non-Farmakologis

a. Istirahat yang Cukup

- Posisi Tidur yang Dianjurkan: Tidur miring ke kiri (left lateral position) dapat meningkatkan aliran darah ke plasenta dan ginjal, sehingga membantu menurunkan tekanan darah.

b. Pemantauan Tekanan Darah Rutin

c. Teknik Relaksasi yang Dianjurkan:

- Pernapasan dalam (deep breathing)
- Meditasi ringan
- Prenatal yoga
- Mendengarkan musik yang menenangkan
- Berbicara dengan orang terdekat

d. Kontrol Kehamilan Teratur

Jadwal Kunjungan ANC untuk Ibu dengan Hipertensi:

- Lebih sering dari ibu hamil normal
- Setiap minggu jika mendekati persalinan atau ada tanda bahaya

Perawatan antenatal (antenatal care ANC) pada kehamilan, untuk wanita dengan hipertensi frekuensi perawatan antenatal bervariasi berdasarkan klasifikasi risiko:

- Hipertensi Kronik

1. Risiko Rendah: wanita dengan tekanan darah yang terkontrol dengan baik dan tanpa faktor risiko tambahan dapat mengikuti jadwal antenatal rutin:

- Kunjungan setiap 4 minggu hingga usia kehamilan 28 minggu.
- Kunjungan setiap 2 minggu dari usia kehamilan 28 hingga 36 minggu.
- Kunjungan setiap minggu dari usia kehamilan 36 minggu hingga persalinan.

2. Risiko Tinggi: wanita dengan tekanan darah yang sulit dikendalikan atau komplikasi tambahan, seperti riwayat preeklamsia atau restriksi pertumbuhan janin, memerlukan pengawasan lebih intensif:

- Kunjungan setiap 2 minggu mulai usia kehamilan 20 minggu

- Hipertensi Gestasional

1. Kasus Ringan:
- Kunjungan awal dijadwalkan setiap 2 minggu, kemudian meningkat menjadi setiap minggu mulai usia kehamilan 32 minggu.
- Pemantauan tekanan darah dan evaluasi kesejahteraan janin, seperti ultrasonografi dan profil biofisik, dilakukan setiap 2–4 minggu.

2. Kasus Berat:
- Pemantauan intensif diperlukan, dengan jadwal kunjungan mingguan atau dua kali seminggu sejak diagnosis.

- Preeklamsia Tanpa Kriteria Pemberat

- Kunjungan mingguan direkomendasikan hingga usia kehamilan 34 minggu.
- Setelah usia kehamilan 34 minggu, kunjungan meningkat menjadi dua kali seminggu untuk memantau tanda-tanda perkembangan penyakit.
- Penilaian maternal meliputi pengukuran tekanan darah, skrinin proteinuria, dan pemantauan enzim hati.

- Preeklamsia Dengan Kriteria Pemberat

1. Pemantauan Maternal:
- Tekanan darah, proteinuria, dan gejala maternal dinilai setiap hari atau dua kali sehari.
- Tes laboratorium rutin, termasuk tes fungsi hati dan jumlah trombosit, sangat penting untuk mendeteksi kondisi yang memburuk.

3. Penerapan Gaya Hidup Sehat dan Pola Makan Seimbang

a. Pola Makan Sehat (**Diet DASH** Modifikasi untuk Ibu Hamil)
Prinsip Utama:
- Batasi asupan garam
- Perbanyak sayur dan buah
- Pilih protein rendah lemak
- Makanan mengandung kalium (tomat, pisang, apel, jeruk dan kentang)
- Konsumsi makanan tinggi kalsium dan magnesium (susu dan kacang kacangan serta sayuran hijau)
- makanan mengandung antioksidan (kacang kedelai dan tempe)

Makanan yang Harus Dihindari:
- Makanan tinggi garam
- Makanan berlemak
- Makanan kalengan
- Minuman berkafein berlebihan (kopi, teh kental)
- Makanan cepat saji
- bumbu penyedap berlebihan

b. Aktivitas Fisik yang Aman
Olahraga yang Dianjurkan:

- Jalan kaki ringan (30 menit/hari)
- Senam hamil
- Yoga prenatal

Olahraga yang Harus Dihindari:

- Angkat beban berat
- Olahraga dengan risiko jatuh

C Cek kesehatan secara rutin

E Enyahkan asap rokok

R Rajin aktivitas fisik

D Diet

I Istirahat cukup

K kelola stress

Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)

1. Melakukan aktivitas fisik secara rutin (minimal 30 menit per hari)
2. Mengonsumsi buah dan sayur
3. Tidak merokok
4. Tidak mengonsumsi alkohol
5. Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala

4. Pencegahan Komplikasi Hipertensi dalam Kehamilan

a. Deteksi Dini
Tanda Bahaya yang Harus Diwaspadai:

- Tekanan darah ⩾160/110 mmHg
- Sakit kepala hebat yang tidak hilang
- Pandangan kabur atau ganda
- Nyeri perut bagian atas yang hebat
- Mual muntah hebat
- Sesak napas
- Bengkak tiba-tiba pada wajah dan tangan
- Gerakan janin berkurang

b. Kepatuhan Pengobatan
Hal yang Perlu Diperhatikan:

- Minum obat sesuai dosis dan waktu yang ditentukan
- Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi dokter
- Laporkan efek samping yang dirasakan
- Bawa catatan obat saat kontrol

c. Persiapan Persalinan
Hal yang Perlu Disiapkan:

- Pilih fasilitas kesehatan yang memadai (minimal RS)
- Siapkan donor darah jika diperlukan
- Kenali tanda-tanda persalinan
- Siapkan transportasi darurat
- Siapkan dokumen (KTP, kartu ANC, hasil lab)

BAB III
PERAN KADER DALAM PENYULUHAN

1. Tugas dan Fungsi Kader dalam Upaya Promotif dan Preventif

a. Pendataan dan Identifikasi
Tugas Kader:

- Mendata semua ibu hamil di wilayah kerja
- Mengidentifikasi ibu hamil dengan faktor risiko tinggi
- Mencatat hasil pengukuran tekanan darah
- Melaporkan temuan ke bidan/puskesmas

b. Pemantauan dan Pengukuran
Kegiatan Pemantauan:

- Mengukur tekanan darah ibu hamil di posyandu
- Menimbang berat badan
- Menanyakan keluhan dan tanda bahaya
- Mengingatkan jadwal kontrol ke bidan/dokter

c. Penyuluhan dan Edukasi
Materi Penyuluhan:

- Pengertian hipertensi dalam kehamilan
- Tanda dan gejala yang perlu diwaspadai
- Cara pencegahan
- Pola makan sehat
- Pentingnya kontrol rutin
- Kapan harus segera ke fasilitas kesehatan

d. Rujukan

Kriteria Rujukan:

- Tekanan darah ≥140/90 mmHg
- Ditemukan tanda bahaya
- Ibu hamil dengan faktor risiko tinggi
- Ada keluhan yang mencurigakan

NOMOR TELEPON DARURAT

CIPUTAT - KOTA TANGERANG SELATAN - BANTEN

Nomor darurat utama di Tangerang Selatan adalah **112**, yang dikelola oleh Pemkot Tangsel untuk situasi gawat darurat (kebakaran, kecelakaan, medis, kriminal, bencana) gratis 24 jam. Bisa menghubungi Layanan semurat spesifik berikut

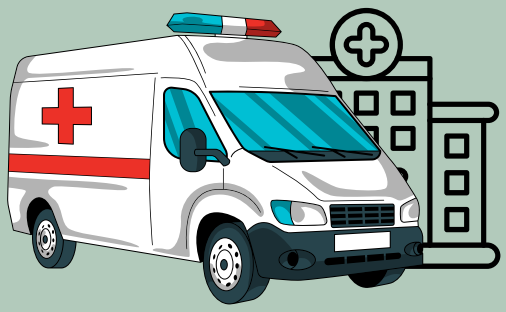
Layanan Darurat Terpadu (TANGSEL Siaga)

112 Tanggap Kebakaran, Kecelakaan, Medis, Kriminal, Bencana

+62 813-8020-1112

Darurat Medis / Ambulans

119 Layanan ambulans dan bantuan medis 24 jam (gratis)



PMI Tangerang Selatan

(021) 2275-6509

Polisi: 110 **Pemadam Kebakaran Tangsel: 0811900074**

PESAN

1. Gunakan layanan hanya untuk kondisi yang benar-benar mendesak
2. Kenali tanda kegawatdaruratan (contoh: tekanan darah ≥160/110 mmHg, kejang, perdarahan, sesak napas)
3. Simpan dan bagikan nomor penting di grup kader (112,119, 110)
4. Jangan menunda rujukan pada kondisi gawat darurat.
5. Pastikan informasi lokasi jelas saat menelepon (sebutkan alamat dan patakan terdekat, serta Dampingi keluarga saat proses rujukan ke rumah sakit.

2. Langkah-Langkah Pelaksanaan Penyuluhan

Tahap 1: Persiapan
Persiapan Materi:

- Tentukan topik yang akan disampaikan
- Siapkan materi dalam bahasa sederhana
- Kumpulkan data dan fakta pendukung

Tahap 2: Pembukaan
Langkah-langkah:

- Salam pembuka dan perkenalan
- Jelaskan tujuan penyuluhan
- Tanyakan apa yang sudah diketahui peserta tentang topik
- Buat suasana nyaman dan santai

Tahap 3: Penyampaian Materi
Tips Penyampaian yang Efektif:

- Gunakan bahasa sederhana dan mudah dipahami
- Berikan contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari
- Gunakan alat peraga untuk memperjelas
- Libatkan peserta dengan pertanyaan
- Selingi dengan cerita atau pengalaman nyata
- Jangan terlalu cepat dalam menjelaska

Tahap 4: Diskusi dan Tanya Jawab
Cara Memfasilitasi Diskusi:

- Beri kesempatan peserta untuk bertanya
- Jawab pertanyaan dengan sabar dan jelas
- Jika tidak tahu jawabannya, jujur dan catat untuk ditanyakan ke bidan
- Dorong peserta untuk berbagi pengalaman

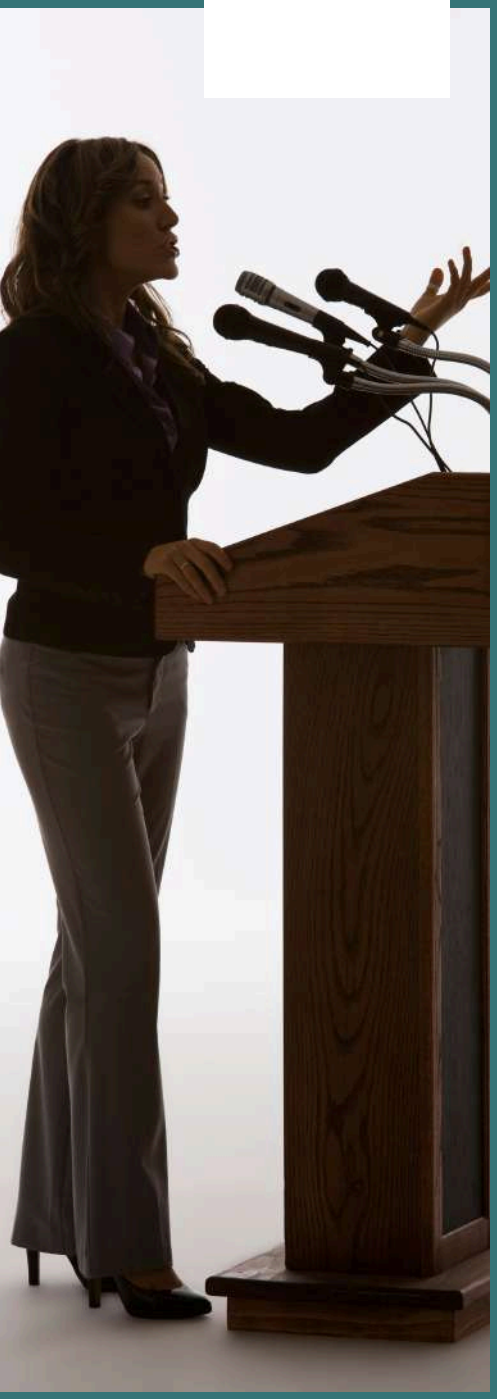
Tahap 5: Evaluasi dan Penutup
Cara Evaluasi:

- Tanyakan kembali poin-poin penting kepada peserta
- Minta peserta menyebutkan tanda bahaya yang diingat
- Berikan pujian atas partisipasi peserta

Penutup:

- Rangkum materi yang telah disampaikan
- Ingatkan untuk kontrol rutin
- Berikan leaflet untuk dibaca di rumah
- Sampaikan jadwal pertemuan berikutnya
- Tutup dengan salam

3. Teknik Komunikasi



a. Bentuk komunikasi dibagi 4 (empat) yaitu.

- Komunikasi personal (komunikasi intra personal dan komunikasi interpersonal).
- Komunikasi kelompok.
- Komunikasi massa.
- Komunikasi media.

b. Tujuan Komunikasi

- Menyampaikan Ide/Informasi/Berita
- Memengaruhi Orang Lain
- Mengubah Perilaku Orang Lain
- Memberikan pedidikan

c. Jenis komunikasi

1. Komunikasi Tertulis
2. Komunikasi Verbal
3. Komunikasi Non Verbal

- Gerak tubuh
- Ekspresi wajah
- Pandangan
- Postur
- Jarak tubuh dan kedekatan
- Sentuhan

d. Cara komunikasi efektif:

- Mendengarkan Aktif (Active Listening): Fokus sepenuhnya pada lawan bicara
- Pesan Jelas dan Singkat: Sampaikan poin utama secara langsung
- Empati dan Pengelolaan Emosi: Pahami perspektif lawan bicara dan kendalikan emosi
- Umpan Balik Konstruktif: Saat memberikan respon, fokus pada masalahnya
- Penyesuaian Gaya Komunikasi: Sesuaikan bahasa dan intonasi
- Verifikasi dan Klarifikasi: Ajukan pertanyaan atau ulangi poin penting untuk memastikan tidak ada salah paham.

4. CARA MENENTUKAN HIPERTENSI PADA IBU HAMIL

1. Alat Pemeriksaan Tekanan Darah

Spignomanometer Raksa

Spignomanometer Jarum

Spignomanometer Digital

2. Cara Pemeriksaan Tekanan Darah

Tahap Pelaksanaan

Alat dan bahan

- Sfigmomanometer (tensimeter).
- Stetoskop.
- Buku catatan tanda vital.
- Pena

Cara kerja

- Jelaskan prosedur pada klien.
- Cuci tangan.
- Atur posisi klien.
- Letakkan lengan yang hendak diukur pada posisi telentang.
- Lengan baju dibuka.
- Pasang manset pada lengan kanan/kiri atas sekitar 3 cm di atas fossa cubiti (jangan terlalu ketat maupun terlalu longgar)
- Tentukan denyut nadi arteri brakhialis
- Letakkan diafragma stetoskop di atas arteri brakhialis dan dengarkan
- Pompa balon udara manset sampai denyut nadi arteri radialis tidak teraba.
- Pompa terus sampai manometer setinggi 20 mm Hg lebih tinggi dari arteri radialis tidak teraba.
- Kempeskan balon udara manset secara perlahan dan berkesinambungan dengan memutar sekrup pada pompa udara berlawanan arah jarum jam.
- Catat tinggi air raksa manometer saat pertama kali terdengar kembali denyut. Nilai ini menunjukkan tekanan sistolik
- Catat tinggi air raksa pada manometer saat terakhir kali terdengar denyut. Nilai ini menunjukkan tekanan ditstolik.
- Catat hasil.
- Cuci tangan setelah prosedur dilakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Aisa, S., Hikmandayani, & Anwar, K. K. (2024). Pelatihan Kader Tentang Pengenalan Hipertensi Dan Pre-Eclampsia Dalam Kehamilan Di Wilayah Pesisir Kelurahan Sawa Kabupaten Konawe Utara. Jurnal Inovasi Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat (Jippm), 4(1), 1–8. https://doi.org/https://doi.org/10.36990/jippm.v4i1.1434
- Anindya, L. (2026). Cara berobat BPJS 2026: Panduan lengkap Faskes 1 ke RS. Ipidiklat.id. https://ipidiklat.id/
- Budayasa, A. A. G. R., Afiatin, Soeryo Kuncoro, A., Juli, C., Harmeiwaty, E., Bachnas, M. A., Aziz, M. A., Hustrini, N. M., & Pratikto Rossana Barack, R. S. (2025). Panduan penatalaksanaan hipertensi pada periode peripartum. Jakarta: Indonesian Society of Hypertension (InaSH).
- Cahya, V. T. R., & Masruroh. (2025). Pendidikan Kesehatan Terhadap Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil Tentang Hipertensi. Journal of Holistics and Health Sciences, 7(2), 411–420. https://doi.org/https://doi.org/10.35473/jhhs.v7i2.634
- Haryanti, P., Dewi, M. K., Isnanto, Nugroho, T., & Khenda, N. A. (2025). Optimalisasi Peran Kader dalam Pencegahan Kegawatdaruratan Maternal: Hipertensi dan Pre-Eclampsia di Masyarakat. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Ilmu Keperawatan Optimal, 1(2), 66–71.
- Hastuti, D. T., Puspitasari, D., Fahrudin, R., & Zulhety. (2018). Keterampilan dasar tindakan keperawatan (Jilid 1). Pilar Utama Mandiri.
- Juniartati, E., & Marsita, E. (2021). Hubungan Pola Makan Dengan Kejadian Hipertensi Pada Ibu Hamil Di Wilayah Kerja Puskesmas Kabupaten Banyumas. Jurnal Kebidanan Khatulistiwa, 7(1), 46–49. https://doi.org/https://doi.org/10.30602/jkk.v7i1.705
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4634/2021 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana Hipertensi Dewasa. Kementerian Kesehatan RI. https://jdih.kemkes.go.id
- Mudlikah, S., Nabila, F., Triastin, S. A., Sulasthia, & Nadhiroh, A. M. (2025). Pencegahan Hipertensi Kehamilan Melalui Promosi dan Edukasi Komplikasi Hipertensi, Gizi Seimbang Dadan Sikap Pada Kader Kesehatan. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 7(3), 547–554. https://doi.org/https://doi.org/10.31960
- Paat, K. M., Meo, M. L. N., & Kundre, R. (2024). Hubungan Perilaku Manajemen Perawatan Diri Dengan Kualitas Hidup Pada Ibu Hamil Yang Mengalami Hipertensi di Puskesmas Kota Manado. Mapalus Nursing Science Journal, 02(02), 28–37.
- Rosita, Febrianti, N., & Tahir, S. (2025). Penyuluhan Kesehatan Tentang Hipertensi Dalam kehamilan di Desa Enu , Kabupaten Donggala , Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kolaboratif Sains, 8(8), 4967–4975. https://doi.org/10.56338/jks.v8i8.8433
- Siregar, P. A. (2022). Komunikasi kesehatan: Teori dan aplikasi. Medan: CV. Merdeka Kreasi Group
- Wardani, R. A., & Herlina. (2020). Terapi komplementer hipertensi pada ibu hamil. Mojokerto: Dian Husada Press.

"KEHAMILAN YANG SEHAT DIMULAI DARI IBU YANG PEDULI PADA DIRINYA SENDIRI."

Panduan Penyuluhan